

中山醫學大學附設醫院

主題名稱	口腔癌 Oral Cancer				
編號	A31000-Q03-W-K02	制定者	N10 韓蕎伊	公布日期	99 年 01 月 20 日
制定單位	護理部	核准者	吳姿蓉	修正日期	113 年 09 月 03 日
版本/總頁數	第 3.7 版/9 頁	審查者	曾翊捷	檢閱日期	114 年 08 月 07 日

一、目的

讓護理人員了解口腔癌的定義、症狀、常見檢查、常見治療、護理問題與護理措施及衛教指導，有更適切之照護能力，提供最佳服務品質。

二、範圍

護理部各單位（含中興分院）。

三、說明

（一）定義

口腔癌泛指口腔黏膜細胞惡化形成惡性腫瘤的總稱，可能侵犯的解剖位置包括嘴唇、頰、上下牙齦、舌前三分之一、白齒後三角區、口腔底、硬顎及舌前三分之二等部分，90%以上為鱗狀上皮細胞癌。

（二）症狀

臨床症狀有口內傷口不易癒合、頸部淋巴結腫大、頸部僵硬、吞嚥與說話困難及口腔疼痛、出血、黏膜出現白斑。

（三）常見檢查

口腔癌可由耳鼻喉科醫師用內視鏡檢查口腔、鼻咽、下咽、喉等，確認是否有病變，有病變處可直接做病理切片確定是否為癌細胞。另外臨床醫師會依疾病嚴重度及需要，安排超音波、電腦斷層、磁振造影、正子攝影與各項抽血檢驗來評估腫瘤侵犯的程度與轉移部位，腫瘤分期確定後便可依個別狀況制定治療計劃。

（四）常見治療

1. 手術治療

主題名稱	口腔癌	制定單位		護理部	
編號	A31000-Q03-W-K02	版本	第 3.7 版	頁碼/總頁數	2/9

據文獻顯示，以手術切除口腔癌其存活率較佳，手術分頸部廓清術與皮瓣顯微重建術兩階段，頸部淋巴廓清術是將腫瘤病灶及周圍淋巴組織徹底切除，為了預防頸部淋巴結擴散，醫師會視情況切除部份下顎骨及周圍軟組織與頸部淋巴結，藉由鈦金屬骨釘骨板與皮瓣來重建傷口。

2. 放射線治療

是以破壞 DNA 的結構，控制癌細胞的生長。病人在行放射線治療前需會診牙科或口腔顎科，評估牙齒蛀牙及牙齦疾病狀況，如有上述症狀則需先治療或拔牙，在齒槽傷口完全復原後才可開始放射線治療，對於第三與第四期的病人，據 NCCN 口腔癌術後治療指引，有合併淋巴莖膜外侵犯或陽性切邊緣者，需合併接受手術、化學性治療與放射線治療，治療過程可能出現口咽部黏膜發炎及潰瘍等口腔黏膜炎症狀，如症狀嚴重會影響進食，而出現惡病質、食慾不振、脫水、營養不良等問題。

3. 化學性治療及標靶治療

是運用藥物來治療癌症的方法，藉由停止癌細胞的生長或直接破壞癌細胞手段來達成制癌的目地，可消滅已擴散到全身各部位的癌細胞，治療過程可能發生口腔黏膜炎症狀。

（五）護理問題

1. 易感染／術後傷口。
2. 疼痛不適／術後傷口。
3. 語言溝通困難／疾病與口腔癌術後有關。
4. 身體心像不一致／因手術造成身體結構或功能改變。
5. 口腔黏膜異常/與接受放射線治療、化學治療導致有關。

（六）護理措施

1. 易感染／術後傷口
 - (1) 監測全血球計數(CBC)並報告 WBC 異常現象。
 - (2) 記錄及檢查傷口滲出液顏色、氣味、濃稠度、癒合情況。

主題名稱	口腔癌	制定單位		護理部	
編號	A31000-Q03-W-K02	版本	第 3.7 版	頁碼/總頁數	3/9

- (3) 觀察傷口敷料外觀。
- (4) 治療前後洗手。
- (5) 依無菌技術收集標本培養以監測感染存在。
- (6) 依醫囑按時給予抗生素。
- (7) 依醫囑以無菌技術換藥。
- (8) 教導保持傷口乾燥及清潔避免壓迫傷口並協助教導翻身方式。
- (9) 教導選擇高蛋白、高維生素飲食，以促進傷口的修復再生。

2. 疼痛不適／術後傷口

- (1) 評估病人的疼痛程度和特徵。
- (2) 評估疼痛加劇的原因。
- (3) 減少或排除疼痛加劇的因素。
- (4) 教導放鬆技巧如：深呼吸、背部按摩、改變姿勢與肢體擺位。
- (5) 教導轉移注意力，如：看電視、聽音樂。
- (6) 依醫囑予物理治療如：熱敷、冷敷。
- (7) 依醫囑給予止痛劑。
- (8) 評估藥物的效果和副作用。
- (9) 鼓勵家屬多予陪伴。

3. 語言溝通困難／疾病與口腔癌術後有關

- (1) 評估病人意識狀態、語言文化、教育程度及肢體動作所表達意義。
- (2) 評估並找出雙方溝通方式（語言、非語言）。
- (3) 教導並提供數種表達需要的方式，如筆或簡易圖片來進行溝通。
- (4) 適當給予獎勵及讚美以增加病人自尊及信心。
- (5) 提供病人練習有效溝通技巧之機會。
- (6) 溝通前後注意病人的反應和表情。

4. 身體心像不一致／因手術造成身體結構或功能改變

- (1) 以主動傾聽、開放式問題，來促進病人表達感受。

主題名稱	口腔癌	制定單位		護理部	
編號	A31000-Q03-W-K02	版本	第 3.7 版	頁碼/總頁數	4/9

- (2) 採溫和漸進方式，鼓勵病人去觸摸及正視患部。
- (3) 多與病人接觸，建立良好治療性人際關係，取得病人信任。
- (4) 當病人開始接受改變，應給予鼓勵。
- (5) 鼓勵病人走出病房，多接觸其它人、事、物，找尋適當方法抒解情緒。
- (6) 介紹相同病人，互相表達感受，彼此交換意見。
- (7) 鼓勵病人習慣別人的眼光，正向的將別人的眼光視為關懷。
- (8) 若發現病人有退縮及拒絕的行為，應瞭解原因並協助解決。

5. 口腔黏膜異常/與接受放射線治療、化學治療導致有關

- (1) 初期病人可能出現口腔黏膜紅腫、無痛性白斑或抱怨口腔有灼熱感，漸漸可能演變味覺改變、咀嚼、吞嚥、說話困難及進食困難，需每班進行口腔黏膜評估和檢查：檢視口腔有無異味、全口可見範圍之黏膜完整性、教導病人用手電筒及鏡子進行口腔檢查。
- (2) 教導飯後 30 分鐘內用生理食鹽水沖洗口腔並漱口，使用海棉、軟毛刷牙，以降低疼痛不適感，如疼痛嚴重可依醫囑由口含漱 2% Xylocaine 及使用各類止痛藥。
- (3) 選擇清淡食物，避免生食、酸辣、堅硬、粗糙及刺激性食物，如：辣椒、芥末、酒類、熱飲；每天至少攝取 3,000 ml 的水分，採漸進式軟質易吞食物，如：豆花、豆腐、布丁、蒸蛋等。
- (4) 教導口腔黏膜炎經常開始於治療一周後出現，初期紅斑，數天後漸漸纖維化及產生滲液，當接受高劑量時，會產生潰瘍、水腫影響傷口癒合，一般於治療結束三至四周後，口腔黏膜會自行修復，如有抽菸會影響口腔黏膜癒合及疼痛的嚴重度和時間。

(七) 衛教指導

1. 維持呼吸道通暢

手術後呼吸道分泌物會增加，因此，每 2 小時應翻身拍背以利痰液咳出。同時由呼吸治療人員進行呼吸功能復健，並給予足夠的氧氣，必要時需從氣切口抽

主題名稱	口腔癌	制定單位		護理部	
編號	A31000-Q03-W-K02	版本	第 3.7 版	頁碼/總頁數	5/9

取痰液。

2. 傷口照護

術後醫護人員會依傷口情況，每天為病人更換敷料或塗抹藥膏。醫療用膠帶經過時間及病人體溫黏性會增強，導致換藥前在撕開醫療用膠帶時，可能會牽扯傷口周圍的皮膚而造成疼痛，建議使用防沾黏醫療用膠帶，可以降低撕除醫療用膠帶時的疼痛，也能降低傷口周圍皮膚的粘著性創傷並減少傷口感染。

3. 口腔清潔

教導病人每天用手電筒及鏡子進行口腔檢查：檢視口腔有無異味、張口檢視可見範圍之黏膜完整性，應經常使用生理食鹽水或漱口水清潔口腔，減少細菌滋生，以免造成感染或不適，適時地使用棉棒清除口腔傷口上的痂皮，維持傷口乾淨；三餐飯後及睡前使用海棉、軟毛刷牙清潔口腔，不可使用含酒精成分的市售漱口水；當口腔黏膜出血時，有可能為血小板太低的症狀，可用冰水漱口，或以紗布加壓出血點，並告知醫護人員做進一步的處理。

4. 營養補給

因為術後不宜立即進食會放置鼻胃管，需暫時由鼻胃管灌食以補給營養，在鼻胃管留置期間內，口水儘量吞入胃內以避免影響傷口癒合，醫師會依傷口狀況逐步給您嘗試從水→流質→軟質食物等，以利拔除鼻胃管，鼻胃管移除後建議少量多餐，採高蛋白、高熱量、高維生素之飲食，食物性質勿生食、酸辣、太冷、太熱、太粗糙或太刺激性，以免刺激口腔黏膜，如有營養其他相關問題可進一步諮詢營養師。

5. 知覺改變

手術後有氣切造口期間，因鼻腔不再吸入空氣而暫時失去嗅覺，進食時可利用視覺和觸覺來感覺食物的美味，以增加食慾。

6. 復健治療

手術或放射線治療可能導致口腔組織攣縮、僵硬或張口困難，需配合復健治療，以減輕上述症狀。除了患部運動外，更重要的是手術後若無姿勢限制時，應早

主題名稱	口腔癌	制定單位		護理部	
編號	A31000-Q03-W-K02	版本	第 3.7 版	頁碼/總頁數	6/9

日下床活動，以減少因固定不動所引起的肺炎，肢體關節僵硬、頭暈等併發症。

7.傷口疼痛

術後因身上有很多傷口及引流管留置或因化學治療、放射線治療，而造成不適，醫護人員會依病人個別疼痛情形及疼痛指數給予由口含漱、口服或注射各類止痛藥物。

8.術後請勿咀嚼檳榔、抽菸或飲酒，並依醫護人員或營養師之指導，按時服藥，注意飲食攝取，隨時觀察傷口，若有紅、腫、熱、痛、不正常分泌物、潰瘍、腫塊等徵象，則應立即回診。

(八) 實施及修訂

本辦法經護理長會議通過後，呈督導會議核准後公布實施，修正時亦同。

四、使用表單

(略)

五、流程圖

(略)

六、參考資料

- (一) 洪雁容、廖君惠(2021)・協助一位口腔癌病患面對癌病復發之護理經驗・新臺北護理期刊，23(1)，121-129。[https://doi.org/10.6540/NTJN.202103_23\(1\).0012](https://doi.org/10.6540/NTJN.202103_23(1).0012)
- (二) 廖婉如、紀慧貞(2017)・一位口腔癌患者接受皮瓣重建術之護理經驗・志為護理，16(5)，114-125。
- (三) 謝季怡、趙麗玫、曾瓊誼(2022)・一位初次確診口腔癌病人之護理經驗・若瑟醫護雜誌，16(1)，30-42。
- (四) 張雅玲、羅玉涵、黃子明、張元玫(2023)・照顧一位下咽癌個案行氣切造口術之護理經驗・秀傳醫學雜誌，1-24。<https://doi.org/10.30185/SCMJ.202303/PP.0017>

主題名稱	口腔癌	制定單位		護理部	
編號	A31000-Q03-W-K02	版本	第 3.7 版	頁碼/總頁數	7/9

(五) 周韋涵、林妙茹、吳佳幸(2018)・照護一位初次罹患口腔癌病人之護理經驗・彰化護理，25(1)，60-73。https://doi.org/10.6647/CN.201803_25(1).0010

(六) 黃靜宜、陳繪竹、黃詩婷、王姮樺、鄭碧芬(2020)・一位初診斷口腔癌病人行廣泛切除手術之照護經驗・高雄護理雜誌，37(2)，120-131。

https://doi.org/10.6692/KJN.202008_37(2).0011

(七) 王靜婷、吳珮菁(2024)・一位壯年男性初次罹患舌癌之術後護理經驗・高雄護理雜誌，41(1)，135-146。https://doi.org/10.6692/KJN.202404_41(1).0011

七、附件

(略)

主題名稱	口腔癌	制定單位		護理部	
編號	A31000-Q03-W-K02	版本	第 3.7 版	頁碼/總頁數	8/9

八、文件修正紀錄

修正日期	版本	修正說明	備註
99.01.20	1.0	新制定	99 年 01 月 20 日護理部照護標準委員會通過
99.08.31	2.0	配合本院 SOP 格式改版	
100.08.31	2.1	潤飾內容詞句	100 年 08 月 31 日護理部照護標準委員會通過
101.08.31	2.2	1.檢視全文修正錯字 2.醫護部改護理部	101 年 08 月 31 日護理部照護標準委員會通過
102.02.08	3.0	配合標準化文件管理辦法修正公布日期及進行年度臨時檢閱	
103.06.30	3.0	年度檢閱，無修正。版本不變動。	
104.08.31	3.1	更新參考資料	104 年 08 月 31 日護理部照護標準委員會通過
105.06.07	3.2	1. 更新定義部份內容。 2. 第三項第(四)目部份內容刪修。 3. 新增參考文獻出處於內文中。	105 年 06 月 07 日護理部照護標準委員會通過
105.08.31	3.3	1. 更新第三項第(一)、(二)、(三)、(四)目之內容。 2. 新增參考文獻出處於內文中。 3. 更新第六項參考文獻資料。	105 年 08 月 31 日護理部照護標準委員會通過
106.08.31	3.3	年度檢閱，無修正。版本不變動。	
107.06.29	3.3	年度檢閱，無修正。版本不變動。	
107.09.12	3.4	1. 第二項新增（含中興分院）。 2. 第三項第四目之 1、2、3 參考資料修訂。	107 年 09 月 12 日護理長會議通過
107.12.13	3.5	1. 與「護理部_A31000-Q03-W-K12_口腔癌之口腔黏膜炎及口腔味覺改變」合併。 2. 第三項第二、三目；第四目之 2、3；第五	107 年 12 月 13 日照護標準組會議通過； 108 年 01 月 09 日護

主題名稱	口腔癌	制定單位		護理部	
編號	A31000-Q03-W-K02	版本	第 3.7 版	頁碼/總頁數	9/9

修正日期	版本	修正說明	備註
		目之 5；第六目之 5；第七目之 3、4、7 內容說明新增及修訂。 3. 第三項第八日本辦法經委員會通過後公布實施，改為護理長會議通過後，呈督導會議核准後公布實施。 4. 第六項新增第六、七、八目。	理長會議通過；108 年 01 月 22 日督導會議通過公布。
108.06.06	3.5	年度檢閱，無修正。版本不變動。	
109.08.06	3.5	年度檢閱，無修正。版本不變動。	
110.10.07	3.5	年度檢閱，無修正。版本不變動。	
111.11.08	3.6	1. 更新第三項第五、六目護理問題。 2. 更新第六項參考文獻資料。 3. 內文參考文獻引用刪除	111 年 10 月 06 日照護標準組會議通過；111 年 10 月 12 日護理長會議通過；111 年 11 月 08 日督導會議通過公布。
112.08.03	3.6	年度檢閱，無修正。版本不變動。	
113.09.03	3.7	1. 新增第三項第六目護理措施說明內容。 2. 新增第三項第七目衛教指導說明內容。 3. 更新第六項參考文獻資料。	113 年 08 月 08 日照護標準組會議通過；113 年 08 月 14 日護理長會議通過；113 年 09 月 03 日督導會議通過公布。
114.08.07	3.7	年度檢閱，無修正。版本不變動。	